

A Evolução do SUS

Para entender o Sistema Único de Saúde, precisamos partir de uma premissa fundamental: o SUS não nasceu pronto. Ele foi criado na **Constituição Federal de 1988**, mas sua estrutura veio sendo construída ao longo de décadas, através de escolhas políticas, normativas e trajetórias históricas que moldaram o sistema que temos hoje.

A história começa lá atrás, com as **campanhas sanitárias** e, posteriormente, com a **Lei Elói Chaves**, que instituiu as **Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs)**, voltadas inicialmente para os ferroviários. Nesse modelo, havia contribuição do empregador e do empregado, formando seguros sociais obrigatórios com gestão descentralizada por sindicatos ou associações. Esse arranjo foi inspirado no chamado **modelo bismarquiano**, nascido na Alemanha Ocidental como resposta às demandas por direitos sociais e à saúde.

Com o tempo, esse modelo foi disseminado para outras categorias profissionais através dos **Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)**, posteriormente unificados no **INPS**. Cada um desses marcos históricos carrega características próprias que ajudam a compreender os diferentes modelos de financiamento em saúde.

O modelo que vigora hoje no Brasil é o **modelo beveridgiano**, inspirado no Relatório Beveridge da Inglaterra e fortemente influenciado pela **Conferência de Alma-Ata**. Esse modelo trabalha com o conceito de **seguridade social**, entendendo a saúde como um **direito humano universal**. Aqui, a saúde é compreendida de forma ampliada, incluindo prevenção, bem-estar, proteção aos direitos, promoção de saúde, tratamento e reabilitação. Trata-se de um sistema **universal e gratuito** para todos os cidadãos.

Vale a pena conhecer outros modelos para fins de comparação e porque aparecem em provas. O **modelo semashko**, adotado na antiga União Soviética e na Coreia do

Norte, também era gratuito e focava na medicina preventiva e diagnóstica, com vacinas obrigatórias. A diferença crucial é que nesse modelo **não era permitida a participação de serviços privados**. Já o **modelo smithiano**, baseado nas ideias do economista liberal Adam Smith, opera com seguros privados e um terceiro pagador. Nesse arranjo, o Estado não possui serviços próprios de saúde; tudo é particular, e o cidadão escolhe o seguro que pode pagar. Quem não tem condições financeiras simplesmente fica sem cobertura. Não por acaso, o sistema americano, que segue essa lógica, é o mais caro do mundo.

O modelo smithiano exemplifica bem o que chamamos de **lei dos cuidados inversos**: quem tem mais recursos e é menos vulnerável acaba tendo acesso a muito mais serviços, enquanto quem mais precisa fica desassistido. O SUS, em contrapartida, propõe-se a ser **equitativo**, garantindo que quem precise mais receba mais atenção, seja por gravidade, vulnerabilidade ou exposição a determinantes sociais de saúde.

Pegadinha clássica de prova: quando a questão perguntar qual o tipo de sistema de saúde brasileiro, a resposta é **seguridade social** (modelo beveridgiano), e não seguro social (modelo bismarquiano). O modelo de seguros sociais influenciou a previdência social brasileira, mas o SUS segue a lógica da seguridade.

Passando agora para o **arcabouço legal**, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a saúde é um **direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas públicas, com um sistema universal e igualitário voltado para promoção, proteção e recuperação da saúde. Contudo, apenas o texto constitucional não era suficiente para desenhar um sistema de saúde para um país de dimensões continentais. Foram necessárias as **Leis Orgânicas de Saúde** e, posteriormente, as **Normas Operacionais Básicas (NOBs)** e as **Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS)**.

A **Lei 8.080/90** estabeleceu os princípios e diretrizes do SUS, definiu as atribuições de cada ente federado, descreveu a constituição do sistema e apontou a possibilidade de **complementariedade do setor privado**. Já a **Lei 8.142/90** trouxe

com força a questão da **participação social** e regulamentou as **transferências intergovernamentais** de recursos financeiros.

O financiamento do SUS é **tripartite**, com recursos provenientes da União, Estados e Municípios, inserido no orçamento da **Seguridade Social**, que contempla não apenas o SUS, mas também o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e a Previdência Social.

A **Emenda Constitucional 29/2000** estabeleceu percentuais mínimos de aplicação em saúde para Estados e Municípios, mas precisou ser regulamentada pela **Lei Complementar 141/2012**. Essa lei detalhou que os **municípios devem aplicar no mínimo 15%** de suas receitas em saúde, os **estados 12%**, e a **União** contribuiria com o valor do ano anterior corrigido pelo PIB, sem reduções. A LC 141 também definiu com clareza quais despesas podem ser consideradas ações e serviços públicos de saúde, excluindo, por exemplo, o saneamento básico, que apesar de ser determinante de saúde, não entra nessa conta.

Atenção para a pegadinha: a EC 29 não estabeleceu percentual fixo para a União; isso só veio na tentativa da **Emenda Constitucional 86/2015**, que propôs uma progressão até atingir 15%. Porém, em 2016, a **Emenda Constitucional 95** (a famosa PEC do Teto dos Gastos) desobrigou a União desses 15%, estabelecendo que ela contribuiria com o valor do ano anterior corrigido pelo **IPCA**, não mais pelo PIB. Essa medida foi considerada uma das maiores políticas de austeridade fiscal da época. Para se ter ideia, em 2024 a União destinou apenas 10,22% à saúde; mesmo no ano de pandemia (2021), a contribuição foi de 11,71%.

Quanto ao **financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS)**, houve mudanças significativas ao longo do tempo. A **NOB 96** criou o **PAB (Piso de Atenção Básica)**, com um componente fixo (valor per capita) e um variável (incentivos para equipes multidisciplinares, horário estendido etc.). Esse modelo vigorou até 2019, quando a **Portaria do Previn Brasil** modificou a lógica de financiamento, introduzindo três componentes: **captação ponderada** (número e perfil da população cadastrada), **pagamento por desempenho** (indicadores de saúde) e **incentivo às ações estratégicas**.

O Previne Brasil recebeu críticas por vincular o financiamento ao cadastro ativo, deixando de fora pessoas que usam os serviços sem estarem formalmente cadastradas. Em 2024/2025, surgiu um **novo modelo de financiamento da APS** com três componentes: **indicadores de indução de boas práticas, componente fixo** (agora considerando dimensionamento territorial e critérios de equidade/vulnerabilidade) e **vínculo e acompanhamento territorial**.

Os novos indicadores de boas práticas incluem:

- 1) **Ações das equipes multiprofissionais (agora chamadas eMulti, não mais NASF)**
- 2) **Média de atendimentos por pessoa assistida pela eMulti**
- 3) **Mais acesso à atenção primária**
- 4) Cuidados com diabéticos
- 5) Cuidados com hipertensos
- 6) Cuidados com gestantes e puérperas
- 7) Cuidados com mulheres na prevenção do câncer
- 8) Cuidados com idosos
- 9) Cuidados no desenvolvimento infantil.
- 10) **Escovação dentária supervisionada em faixa etária escolar**
- 11) **Primeira consulta odontológica programada**
- 12) **Tratamento odontológico concluído**
- 13) **Tratamento restaurador atraumático**
- 14) **Procedimentos odontológicos preventivos**
- 15) **Taxa de exodontias realizadas**

Uma novidade importante é que o **Agente Comunitário de Saúde (ACS)** ganha papel central, sendo obrigatória sua visita domiciliar pelo menos duas vezes por semestre para pacientes crônicos, gestantes, idosos e recém-nascidos. Na parte odontológica, os indicadores incluem escovação supervisionada, primeira consulta odontológica, tratamento concluído, tratamento restaurador atraumático, procedimentos preventivos e taxa de exodontias.

Passando para a **gestão do SUS**, a Constituição estabelece um sistema **regionalizado, hierarquizado, descentralizado**, porém com **direção única em cada esfera de governo**. O atendimento deve ser **integral**, com prioridade para atividades preventivas sem prejuízo das assistenciais, e com **participação da comunidade**.

A **participação social** é institucionalizada através de duas instâncias previstas na Lei 8.142: as **Conferências de Saúde** e os **Conselhos de Saúde**. As Conferências ocorrem a cada 4 anos (podem ser antecipadas em caso de crise sanitária) nos níveis municipal, estadual e nacional, reunindo diversos segmentos da sociedade para elaboração de políticas públicas. Os Conselhos são órgãos **permanentes e deliberativos** com composição **paritária**: 50% de usuários (representados por associações de moradores, igrejas, centrais sindicais, movimentos sociais) e 50% divididos entre trabalhadores de saúde (25%) e gestores (25%). Existem conselhos locais, municipais, estaduais e nacionais.

A **hierarquização e regionalização** ganharam contornos mais definidos com a **NOAS 2001/2002**, que estabeleceu maior responsabilidade dos municípios sobre a APS e instituiu o **Plano Diretor de Regionalização (PDR)**, organizando os **Departamentos Regionais de Saúde (DRS)**. A ideia é que nem todo município precisa dispor de todos os serviços; a articulação regional permite que o paciente acesse recursos complementares em municípios vizinhos dentro de sua região de saúde.

Em 2006, foi firmado o **Pacto pela Saúde**, um acordo tripartite entre União, Estados e Municípios para garantir a unidade do sistema respeitando as diferenças regionais. O Pacto tem três dimensões: **Pacto pela Vida** (prioridades de saúde), **Pacto em Defesa do SUS** (fortalecimento do sistema) e **Pacto de Gestão** (responsabilidades de cada ente).

Para viabilizar essa gestão compartilhada, existem instâncias de articulação. Os **COSEMS** são Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (âmbito estadual); o **CONASS** é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (secretários estaduais); e o **CONASEMS** é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Além disso, existem as **Comissões Intergestores Bipartites (CIB)**, com representação de Estado

e Municípios, e a **Comissão Intergestores Tripartite (CIT)**, com representantes do Ministério da Saúde, do CONASS e do CONASEMS.

O **Decreto 7.508/2011** regulamentou a Lei 8.080 e trouxe conceitos fundamentais. Definiu **região de saúde** como um espaço geográfico contínuo com características culturais, econômicas e de transporte semelhantes, onde se articulam serviços complementares. Estabeleceu as **portas de entrada do SUS** (atenção primária, urgência/emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto como os CTAs). Policlínicas, por exemplo, não são portas de entrada; o paciente é referenciado a partir da atenção primária. Essas regiões de saúde também vão ter uma Comissão Intergestora própria para discussão, podendo ser chamada de Comissão intergestora regional (CIR), Ou Comissões Intergestores de Regiões de Saúde Ampliadas (CIRA), sendo estas compostas por representantes do estado e representantes dos municípios da região de saúde.

As **Redes de Atenção à Saúde (RAS)**, estabelecidas pela **Portaria 4.279/2010**, organizam serviços de diferentes densidades tecnológicas de forma integrada, com relações de referência e contrarreferência. A **atenção primária é ordenadora das redes**, coordenando o cuidado e os fluxos de encaminhamento. As principais redes temáticas são: **Rede Cegonha** (materno-infantil), **Rede de Atenção às Urgências e Emergências**, **Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)**, **Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência** e **Rede de Atenção às Doenças Crônicas**.

A **Rede de Atenção Psicossocial** merece destaque especial por sua construção histórica ligada à **Reforma Psiquiátrica**. Havia uma crítica contundente ao modelo manicomial, considerado violento e excludente, associado à higienização social. Influenciado pelo movimento italiano de Franco Basaglia, o Brasil promoveu a transição para um modelo psicossocial. A **Lei 10.216/2001 (Lei Paulo Delgado)** consolidou essa mudança, estabelecendo a nova política de saúde mental baseada em **serviços comunitários substitutivos** (não complementares) aos hospitais psiquiátricos. O foco passou a ser a **autonomia, reinserção social e cuidado humanizado**, mantendo o usuário em seu território e comunidade.

Outro ponto importante para provas: **território** e **região de saúde** são conceitos distintos. O usuário pode ser atendido fora de seu território (área de abrangência de uma UBS, por exemplo), mas dentro de sua região de saúde. Um CAPS pode receber usuários de vários territórios, desde que pertençam à mesma região.

RESUMO DE GATILHOS

- O SUS é um sistema de **seguridade social** (modelo beveridgiano), criado pela **Constituição Federal de 1988**, com financiamento **tripartite**.
- A EC 29 definiu percentuais mínimos para Estados (12%) e Municípios (15%), regulamentados pela **LC 141/2012**.
- A União contribui com o valor do ano anterior corrigido pelo IPCA (EC 95). A gestão é **descentralizada, hierarquizada e de comando único**, com participação social através de **Conselhos** (permanentes, paritários, deliberativos) e **Conferências** (a cada 4 anos).
- As **RAS** são ordenadas pela atenção primária.
- A **Reforma Psiquiátrica** (Lei 10.216/2001) substituiu o modelo manicomial por serviços comunitários centrados na autonomia do usuário.